Altadis
LA VIDA, NECESITA UN BUEN ALIADO

Acizan®
Levetiracetam

Acizan® 100mg-ml solucion oral Acizan® 500mg Acizan® 1000mg
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El levetiracetam es un fármaco antiepiléptico derivado de la pirrolidona con características únicas que le imprimen diferencias sustan-ciales con respecto al resto de fármacos de su grupo. Es eficaz en una amplia gama de crisis epilépticas y con un mecanismo de acción principal diferente de los demás. MECANISMO DE ACCIÓN: El mecanismo de acción de levetiracetam está todavía por dilucidar, pero parece ser diferente de los mecanismos de acción de los antiepilépticos actuales. Los estudios in vivo e in vitro sugieren que levetiracetam no altera la neurotransmisión normal y las características básicas de la célula. Estudios in vitro muestran que levetiracetam afecta los niveles intraneuronales de Ca2+ mediante inhibición parcial de las corrientes de Ca2+ tipo N, y reduciendo la liberación de Ca2+ de la reserva intraneuronal. Además, invierte parcialmente la reducción de corrientes dependientes de GABA y glicina inducidas por zinc y ß-carbolinas. Por otra parte, estudios in vitro muestran que levetiracetam se une a un punto específico en el tejido cerebral de roedor. Este punto de unión específico es la proteína 2A de las vesículas sinápticas, el cual parece estar involucrado en la fusión de vesículas y en la exocitosis de neurotransmisores. Levetiracetam y sus análogos han mostrado un orden de afinidad por la unión a la proteína 2A de las vesículas sinápticas que se correlaciona con la potencia de la protección contra los ataques epilépticos en el modelo audiogénico de epilepsia en ratón. Este hallazgo sugiere que la interacción entre levetiracetam y la proteína 2A de las vesículas sinápticas parece contribuir en el mecanismo de acción del fármaco como antiepiléptico. Levetiracetam induce una protección de la crisis en un amplio rango de modelos animales de epilepsia parcial y de generalizada primaria sin efecto pro-convulsivo. El metabolito primario es inactivo. En el hombre, la actividad en ambas condiciones de epilepsia, parcial y generalizada (descarga epileptiforme/respuesta fotoparoxismal), ha confirmado el amplio espectro del perfil farmacológico de levetiracetam. Terapia concomitante en el tratamiento de las crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en adultos, adolescentes, niños y lactantes desde 1 mes de edad, con epilepsia INDICACIONES: Dentro de las indicaciones de LEV destaca su uso en la porfiria, por ser soluble en agua, por usos por otros FAE, su absorción lineal, rápida independiente de la ingestión de comida. La primera indicación en crisis focales, tabletas de 250, 500, 750 y 1000 mg. Iniciando dosis de 50 mg, por kilo de peso, con dosis total de 1500 a 3000 mg. En adultos la dosis promedio es de 2000mg. No debe usarse en individuos como medida profiláctica, ya que no actúan en neuronas normales. Actúa por mecanismo de vía canales de calcio, potasio, vuelva a capturar de neurotransitor receptoras y otras en sitios alostericos, descarbozilador delgada. Ayudaría en tratamientos de focos en espejos y epilepsias crónicas, crisis focales y generalmente focalizadas. No se ha detectado diferencias étnicas por sexo y edad. Se utiliza cada 12 horas y el porcentaje de absorción por saturación del sistema de e: intestinales. Más 1 a 2 horas hasta 4 horas. En la distribución une las proteínas en un 10%, por lo que atraviesa bien la Barrera Hemato Encefálica, puede aumentar los niveles de: fenitoina, ácido valproico y tiogabina. DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: Monoterapia para adultos y adolescentes mayores de 16 años. La dosis inicial recomendada es de 250 mg dos veces al día, la cual debe aumentarse hasta la dosis terapéutica inicial de 500 mg dos veces al día tras dos semanas de tratamiento. La dosis puede aumentarse en función de la respuesta
clínica con 250 mg dos veces al día cada 2 semanas. La dosis máxima es de 1.500 mg dos veces al día. Terapia concomitante para adultos (≥18 años) y adolescentes (de 12 a 17 años) con un peso de 50 Kg. o superior. La dosis terapéutica inicial es de 500 mg dos veces al día. Esta dosis se puede instaurar desde el primer día de tratamiento. Dependiendo de la respuesta clínica y de la tolerabilidad, la dosis diaria se puede incrementar hasta 1.500 mg dos veces al día. La modificación de la dosis se puede realizar con aumentos o reducciones de 500 mg dos veces al día cada dos a cuatro semanas.
Reg San No INVIMA 2015M-0016451 - Reg San No INVIMA 2016M-0016784 - Reg San No INVIMA 2016M-0016783

Bruliva®
Escitalopram

Bruliva® 10 mg tabletas Bruliva® 20 mg tabletas.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El escitalopram es el enantiómero S del inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, citalopram. Como el racémico del que deriva, el escitalopram es un agente antidepresivo, que actúa inhibiendo selectivamente la recaptación de serotonina en la hendidura sináptica interneuronal, incrementando la concentración sináptica de serotonina y, consecuentemente, la activación de las vías serotoninérgicas neurales. Carece prácticamente de efectos sobre otros receptores. MECANISMO DE ACCIÓN: Una serie de estudios in vitro e in vivo en animales indica que el escitalopram es un inhibidor de la recaptación de la serotonina sumamente selectivo, con unos efectos mínimos sobre la recaptación de la norepinefrina y de la dopamina. El escitalopram es al menos 100 veces más potente que el enantiómero R como inhibidor de la recaptación de la serotonina y como inhibidor del transporte de la serotonina neuronal. El tratamiento a largo plazo con escitalopram no induce tolerancia en los modelos de depresión en las ratas. El escitalopram prácticamente no tiene efectos sobre los diversos receptores de serotonina (5HT 1 a 7), de dopamina (D1 a 5), de histamina (H 1 a 3),de muscarina (M 1 a 5), de benzodiazepinas y alfa- y beta-adrenérgicos. Igualmente, tiene poca afinidad hacia los diversos canales iónicos (Na + , K + , Cl - , y Ca ++). Por estos motivos, el escitalopram tiene menos efectos secundarios de tipo colinérgico, sedantes o cardiovasculares que otros fármacos psicótropos que tienen alguna afinidad hacia los receptores anteriores. Después de una dosis oral de 10 mg, la absorción es casi completa e independiente de la ingestión de alimentos. Las máximas concentraciones plasmáticas se

alcanzan a las 5 horas. Igual que el citalopram, la biodisponibilidad del escitalopram es del 80%. Con una dosis de 10 mg/día, las concentraciones de equilibrio ("steady state") se alcanzan a los 7 días. Las concentraciones medias en estado de equilibrio de 50 nmol/l (intervalo 20 a 125 nmol/l) se alcanzan a una dosis diaria de 10 mg. Una vez en la circulación sistémica el escitalopram se distribuye ampliamente siendo el volumen aparente de distribución tras la administración oral es de 12-26 l/kg aproximadamente La unión del escitalopram y de sus metabolitos principales a las proteínas plasmáticas es inferior al 80%. INDICACIONES: Tratamiento de episodios depresivos mayores.tratamiento del trastorno de angustia con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de ansiedad social (fobia social). DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: Vía oral: - Adultos: Episodios depresivos mayores: 10 mg/24 h, que se podrá aumentar hasta un máximo de 20 mg/24 h según respuesta. Generalmente, son necesarias 2-4 semanas para obtener respuesta. Después de la resolución de los síntomas, se requiere un periodo de tratamiento de al menos 6 meses. Trastorno de angustia con o sin agorafobia: 5 mg/24 h durante la primera semana, después 10 mg/24 h, pudiendo llegar hasta 20 mg/24 h según respuesta. La máxima respuesta se alcanza a los 3 meses de tratamiento. Trastorno de ansiedad social: 10 mg/24 h durante 2-4 semanas, tras lo que se podrá reducir la dosis a 5 mg/24 h o aumentar hasta 20 mg/24 h. Se recomienda mantener el tratamiento durante 12 semanas. Se ha evaluado durante 6 meses el tratamiento en pacientes respondedores, pudiendo individualizarse para la prevención de recaídas. Se recomienda reevaluar el beneficio del tratamiento.

Reg San No INVIMA 2016M-0016889 - Reg San No INVIMA 2016M-0016966

Desfatigan®
Sertralina

Desfatigan® 50 mg tabletas Desfatigan® 100 mg Tabletas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La Sertralina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina de administración oral, aunque es un potente inhibidor, no produce sedación, no interfiere con la actividad psicomotora, no posee afinidad por los receptores colinérgicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, adrenérgicos ni del ácido γ aminobutírico (GABA). Está libre de producir dependencia psicofisiológica. MECANISMO DE ACCIÓN: La SERTRALINA está indicada como antidepresivo. Manejo del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y del trastorno de Pánico. La sertralina se administra por vía oral y se absorbe muy bien por el tracto digestivo, si bien su administración con los alimentos incrementa en un 25% las concentraciones plasmáticas máximas y se reduce el tiempo necesario para alcanzar estas. La sertralina se une extensamente a las proteínas del plasma, pero al unirse a la glicoproteína ácida a1, no compite con la warfarina o el propranolol. La sertralina experimenta un extenso metabolismo de primer paso, siendo la N-desmetilsertralina el principal metabolito. Este muestra una actividad mucho menor que la sertralina como inhibidor de la recaptación de la serotonina. Tanto la sertralina como su metabolito experimentan seguidamente una desaminación oxidativa, una reducción, y una hidroxilación siendo finalmente excretados como conjugados del ácido glucurónico. Prácticamente no se detecta en la orina sertralina sin metabolizar, si bien en las heces se recupera entre el 12 y 14% de la dosis administrada. La semi-vida de eliminación de la sertralina es de unas 24 horas. En adultos jóvenes, el estado de equilibrio ("steady state")se alcanza en una semana. En los ancianos, el aclaramiento se reduce en un 40% y, el estado de equilibrio sólo se alcanza a las 3-4 semanas. INDICACIONES: El principio activo sertralina es un fármaco perteneciente al grupo de medicamentos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Esta sustancia está indicada en: - Tratamiento de los síntomas de la depresión. Una vez obtenida una respuesta satisfactoria, la continuación del tratamiento con sertralina es eficaz para prevenir las recaídas del episodio inicial de depresión o la aparición de nuevos episodios depresivos.- Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) en pacientes adultos y pediátricos (niños y adolescentes). - Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia (miedo a espacios abiertos). - Tratamiento del trastorno por estrés postraumático (TEP). DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: La dosis recomendada es de una tableta de 50 mg al día sin que el horario de las comidas interfiera con la absorción del medicamento. El efecto terapéutico se inicia al cabo de unos siete días y se alcanza de las dos a las cuatro semanas. Frente a una respuesta pobre al cabo de las cuatro semanas, la dosis se puede incrementar paulatinamente hasta 200 mg/día. En los adultos mayores no se requiere hacer ajuste de la dosis.

Reg San No INVIMA 2016M-0016895 - Reg San No INVIMA 2016M-0016949

Dinive®
Memantina

Dinive® 20mg tabletas Dinive® 10mg tabletas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La memantina es un fármaco derivado de la amantadina que pertenece a la familia de los antagonistas de receptor de NMDA. Los resultados de las Investigaciones realizadas con la memantina han puesto de manifiesto que este fármaco previene el deterioro y la muerte de las neuronas asociadas a una serie de enfermedades nerviosas degenerativas, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington y el dolor neuropático. MECANISMO DE ACCIÓN: En determinadas condiciones patológicas, las neuronas lesionadas o deterioradas liberan cantidades excesivas del aminoácido glutamato, uno de los más importantes neurotransmisores excitatorios. Este exceso de neurotransmisor, actuán sobre los receptores NMDA de las membranas de las neuronas próximas, receptores que a su vez activan los canales iónicos, que permanecen abiertos demasiado tiempo, permitiendo la entrada de Ca++. Como consecuencia del aumento de calcio intracelular, las células se hinchan y estallan, liberando el glutamato que almacenan. Este glutamato estimula a su vez los receptores de NMDA cerrando u círculo vicioso cuyo resultado final es la muerte de la neurona en el área afectada. Revisión sistemática de ensayos clínicos controlados y aleatorizados con memantina en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA) en fase moderada y avanzada, en la que se analiza la efectividad de este fármaco en el área funcional. De siete ensayos clínicos, cuatro de ellos incluían a pacientes con demencia vascular y EA y el resto sólo esta última patología. La revisión incluye 1.439 pacientes de edad media 72 años. La dosis de memantina habitual fue 20 mg/día. La duración de los ensayos varió entre 6 y 28 semanas. Al usar la escala ADCS-ADL se encontró una diferencia estadísticamente significativa a favor de memantina (diferencia de medias, 1,70; intervalo de confianza del 95%, 0,63-2,76; p = 0,002) y de 3,4 puntos a favor de memantina (p = 0,003) con la versión ADCS-ADLsev. El tratamiento con memantina parece mejorar las actividades de la vida diaria en la EA, precisa un tiempo menor de cuidado y utilización de recursos asistenciales y retrasa la institucionalización. INDICACIONES: La memantina pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como medicamentos anti-demencia.La pérdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer se debe a una alteración en las señales del cerebro. El cerebro contiene los llamados receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) que participan en la transmisión de señales nerviosas importantes en el aprendizaje y la memoria. Este medicamento pertenece al grupo de medicamentos llamados antagonistas de

los receptores NMDA. La memantina actúa sobre estos receptores mejorando la transmisión de las señales nerviosas y la memoria.La memantina se utiliza en el tratamiento de pacientes con enfermedad de Alzheimer de moderada a grave. Medizzine le recomienda que consulte a su medico si desconoce la razón por la que le ha prescrito memantina DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: La dosis recomendada de memantina en pacientes adultos y ancianos es de 20 mg administrados una vez al día. Para reducir el riesgo de efectos adversos, esta dosis se alcanza gradualmente siguiendo el siguiente esquema diario: Semana 1: medio comprimido de 10 mg ó 10 gotassemana 2: un comprimido de 10 mg ó 20 gotas semana 3: un comprimido y medio de 10 mg ó 30 gotas semana 4 y siguientes: dos comprimidos de 10 mg una vez al día ó 40 gotas.Posología para pacientes con insuficiencia renal. Si padece problemas de riñón, su médico decidirá la dosis apropiada para su condición. En este caso, su médico debe controlar periódicamente su función renal.
Reg San No INVIMA 2015M-0016567 - Reg San No INVIMA 2015M-0016127

Epilfarmo®
Mirtazapina

Epilfarmo® 30mg tabletas
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Mirtazapina pertenece al grupo de medicamentos llamados antidepresivos. Mirtazapina se utiliza en el tratamiento de episodios de depresión mayor. Medizzine le recomienda que consulte a su medico si desconoce la razón por la que le ha prescrito mirtazapina. MECANISMO DE ACCIÓN: Antidepresivo, tetracíclico derivado piperazinoazepínico, análogo de la mianserina. Su acción antidepresiva deriva de su capacidad de modificar la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. Mirtazapina actúa antagonizando los receptores de serotonina (5-HT), especialmente los subtipos 5-HT2 y 5-HT3, así mismo, es un antagonista potente de los receptores alfa2-adrenérgicos presinápticos, aumentando la neurotransmisión adrenérgica, casi sin modificar la recaptación de noradrenalina. También posee propiedades antihistamínicas sobre los receptores histaminérgicos H1, responsable del efecto sedante, especialmente al comienzo del tratamiento. Posee actividad anticolinérgica muy débil. La respuesta terapéutica es mayor en presencia de síntomas tales como anhedonia, inhibición psicomotora, despertar temprano y pérdida de peso. Mirtazapina es un antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico específico que favorece la transmisión de noradrenalina y serotonina sin inhibir la recaptación de ambos neurotransmisores. La droga ha resultado efectiva para el tratamiento del estrés postraumático, los trastornos primarios de la ansiedad, el dolor central consecutivo al síncope y diversos cuadros depresivos. Los autores revisan especialmente el uso de mirtazapina en pacientes con depresión mayor. INDICACIONES: Episodios de depresión mayor. DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: Vía oral: - Adultos y ancianos: inicialmente, 15-30 mg/día (la dosis mayor se tomará por la noche antes de acostarse), ajustando la dosis hasta un rango usual de 15-45 mg/24 h. En ancianos, el aumento de dosis debe realizarse bajo supervisión médica. - Insuficiencia hepática o renal: el aclaramiento de mirtazapina puede disminuir en insuficiencia hepática o renal. - Nota: se recomienda continuar el tratamiento hasta la desaparición de los síntomas durante 4-6 meses. Posteriormente, se deberá abandonar el tratamiento gradualmente. El tratamiento proporciona respuesta generalmente en 2-4 semanas. Si la respuesta es insuficiente se podrá aumentar hasta la dosis máxima, aunque si no hay respuesta en otras 2-4 semanas se deberá interrumpir el tratamiento. - Normas para la correcta administración del medicamento: se podrá administrar una vez al día, preferiblemente como dosis única por la noche antes de acostarse. También se podrá administrar en subdosis divididas a partes iguales durante el día (mañana y noche). Presentación en comprimidos "Flas": Para evitar que el comprimido se aplaste, no presione el alveolo. Saque el comprimido de su alveolo con las manos secas y póngaselo en la lengua. El comprimido se disgregará rápidamente y puede tragarse sin agua. Cada blister contiene 6 alvéolos, separados por líneas perforadas. Doble el blíster, separe un alvéolo siguiendo las líneas perforadas. Separe cuidadosamente la lámina del alveolo por la esquina indicada con una flecha.
Reg San No INVIMA 2016M-0016987

Prazentol®
Aripiprazol

Prazentol® tabletas 15mg Prazentol® solucion frasco x 150 ml 1mg/ml copa y jeringa dosificadora
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El aripiprazol es un fármaco antipsicótico que reune las propiedades de ser un agonista parcial de los receptores D2 de la dopamina y 5HT1a de la serotonina y un antagonista de los receptores 5HT2a de la serotonina. Se utiliza en el tratamiento de la esquizofrenia. MECANISMO DE ACCIÓN: en los modelos animales de hiperactividad dopaminérgica el aripiprazol presenta las propiedades de un antagonista y en los modelos animales de hipoactividad dopaminérgica las propiedades de un agonista. In vitro el aripiprazol presenta una alta afinidad hacia los receptores D2 y D3 dopaminérgicos, 5HT1a y 5HT2a serotoninérgicos y una moderada afinidad hacia los receptores D4 dopaminérgicos, 5HT2c y 5HT7, αa-1 adrenérgicos y H1 de la histamina. El aripiprazol presenta también una moderada afinidad hacia el lugar de recaptación de serotonina pero no muestra afinidad hacia los receptores muscarínicos. La interacción con otros receptores distintos de los subtipos de dopamina y serotonina puede explicar algunos de los otros efectos clínicos de aripiprazol. El aripiprazol en dosis de 0,5 a 30 mg administrados una vez al día a voluntarios sanos durante 2 semanas, produjo una reducción dosis dependiente en la unión del 11C-racloprida, que es un ligando del receptor D2/D3 en el caudado y putamen, tal como se observó por tomografía de emisión de positrones. INDICACIONES: El principio activo aripiprazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados antipsicóticos. Se utiliza para tratar adultos que padecen una enfermedad caracterizada por síntomas tales como oír, ver y sentir cosas que no existen, desconfianza, creencias erróneas, habla incoherente y monotonía emocional y de comportamiento. Las personas en este estado pueden también sentirse deprimidas, culpables, inquietas o tensas. DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: La dosis inicial y de mantenimiento recomendada con Aripiprazol es de 15 mg/día, administrada una vez al día sin tomar en consideración las comidas. En los estudios clínicos se ha establecido, que dosis de 15-30 mg al día, son efectivas. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con daño renal, daño hepático (clase A, B y C de Child-Pugh). No se ha establecido la eficacia y seguridad en pacientes menores de 18 años. No se requiere ajuste de dosis en sujetos 65 años, aunque la experiencia en esta población es limitada. Se debe tomar en consideración la posibilidad de reducir la dosis diaria en pacientes que toman múltiples medicamentos concomitantes que inhiben las enzimas CYP3A4 y CYP2D6.
Reg San No INVIMA 2016M-0017230

Proclor® Pregabalina

Proclor® 75 mg capsulas duras Proclor®150 mg capsulas duras Proclor® 300 mg capsulas duras

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: La Pregabalina es un análogo del ácido γ-aminobutírico (GABA), pero no se une directamente a ninguno de los subtipos de receptores de GABA (GABAa, GABAb o GABAc) o al sitio de unión de las Benzodiacepinas. La Pregabalina es un anticonvulsivante con gran efectividad en el manejo del dolor neuropático, la fibromialgia, el trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y, en conjunto con otros medicamentos, para las convulsiones parciales (coadyuvante). MECANISMO DE ACCIÓN: La Pregabalina se une con alto grado de afinidad al sitio α2δ (una subunidad estructural auxiliar) de los de los canales de calcio (Ca2+) dependientes de voltaje en el sistema nervioso. Esto reduce el tráfico de Ca2+ y de las corrientes dependientes del mismo, provocando la inhibición de la liberación de neurotransmisores, como la noradrenalina, la sustancia P y el glutamato, lo que explicaría su efectividad en el manejo del dolor y la nocicepción. Evidencia de modelos animales con lesiones nerviosas y dolor persistente, sugieren que la actividad anti-nociceptiva de la pregabalina puede estar mediada por las interacciones con las vías serotoninérgicas y noradrenérgicas originadas en el tallo cerebral, que modulan la transmisión ascendente de las sensaciones dolorosas desde la médula espinal. En los cultivos celulares de neuronas, con la aplicación prolongada al medio de cultivo de Pregabalina, no se encontraron alteraciones en la respuesta a GABA o en la concentración de ésta; tampoco alteró la recaptación ni el metabolismo del neurotransmisor. De todas maneras, si se produjo un aumento en la densidad de la proteína transportadora de GABA y en la tasa de transporte de GABA funcional. No se ha encontrado evidencia que la Pregabalina produzca algún bloqueo o alteración de los canales de Sodio, no es afín ni activa a ninguno de los subtipos de receptores opiodes y no altera la actividad de ninguna de las formas conocidas de la Ciclooxigenasa. Es inactiva en los receptores de Serotonina y Dopamina y no altera el metabolismo ni la recaptación de Dopamina, Serotonina o Noradrenalina. La pregabalina es una sustancia que actúa a nivel cerebral y medular, donde se une a la subunidad alfa-2-delta de los canales de calcio voltaje dependientes e inhibe la exocitosis de neurotransmisores importantes en términos de analgesia, como el glutamato y la sustancia P. Dicho efecto se ve potenciado mediante la despolarización prolongada o el antecedente de inflamación. El gabapentín es empleado para el tratamiento de los pacientes con dolor neuropático. Tiene un buen perfil de tolerabilidad y no presenta interacciones farmacológicas significativas. No obstante, su biodisponibilidad es no lineal y se requiere titulación de la dosis para alcanzar un nivel terapéutico. En cambio, la pregabalina tiene una farmacocinética lineal. INDICACIONES: PREGABALINA MK® está indicada como coadyuvante de convulsiones parciales, con o sin generalización secundaria, en pacientes a partir de los 12 años de edad. Tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos. Tratamiento del dolor neuropatico central en adultos. Manejo del síndrome de fibromialgia. Para el manejo del trastorno de la ansiedad generalizada (TAG). DOSIFICACIÓN/ POSOLOGÍA: El rango de dosificación de la Pregabalina se encuentra entre 150 mg y 600 mg al día. Esta dosis debe ser repartida en dos a tres tomas al día. En aquellos pacientes en los cuales no se logra una respuesta terapéutica durante dos a cuatro semanas de tratamiento con dosis de hasta 300 mg/día y presentan buena tolerabilidad a la Pregabalina, se les puede incrementar la dosis hasta 300 mg dos veces al día o 200 mg tres veces al día (600 mg/día). La Pregabalina puede ser administrada con o sin las comidas. Inicio de acción: Para el tratamiento del dolor, postquirúrgico, se ha utilizado la Pregabalina mostrando un inicio de acción en aproximadamente 30 minutos. Neuropatía diabética periférica: Inicial: 50 mg tres veces al día (150 mg/día). Esta dosis se puede incrementar hasta 100 mg tres veces al día (300 mg/día) en el plazo de una semana, teniendo en cuenta los resultados clínicos (eficacia y tolerabilidad). Esta dosis final (300 mg/día) es la dosis recomendada para pacientes con un aclaramiento renal de creatinina de al menos 60 mL/min. No obstante, en algunos casos de dolor neuropático severo se pueden utilizar dosis de hasta 600 mg/día. Neuralgia postherpética: Inicial: 75 mg dos veces al día o 50 mg tres veces al día (150 mg/día).

Reg San No INVIMA 2016M-0017130 - Reg San No INVIMA 2016M-0017165 - Reg San No INVIMA 2016M-0017333

Tecnozida® Micofenolato de Mofetilo

Tecnozida® Tabletas recurbiertas 500mg

FORMA FARMACÉUTICA: Tabletas 500mg VÍA ADMINISTRACIÓN: Oral INDICACIONES: En combinación con ciclosporina y corticosteroides, está indicado para la profilaxis del rechazo agudo de trasplante en pacientes sometidos a trasplante alogénico renal, cardíaco o hepático. CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: Contraindicaciones: Este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al Micofenolato de Mofetilo (MMF) o al Acido Micofenólico (MPA). El Micofenolato de Mofetilo está contraindicado en mujeres en período de lactancia. Precauciones y advertencias: Los pacientes que reciben Micofenolato de Mofetilo como parte de un tratamiento inmunosupresor en combinación con otros medicamentos, presentan un mayor riesgo de desarrollar linfomas u otros tumores malignos, especialmente de la piel. El riesgo parece estar relacionado con la intensidad y duración de la inmunosupresión más que con el uso de un fármaco determinado. Como norma general para minimizar el riesgo de cáncer de piel, la exposición a la luz solar y a los rayos UV se debe limitar esto con el uso de ropa protectora y usar un protector solar con factor de protección alto. Se recomienda no iniciar el tratamiento con Micofenolato de Mofetilo hasta disponer de una prueba de embarazo negativa. Se debe utilizar un tratamiento anticonceptivo efectivo antes de comenzar el tratamiento, a lo largo del mismo y durante las seis semanas siguientes a la terminación del tratamiento con Micofenolato de Mofetilo. Debe indicarse a las pacientes que consulten inmediatamente a su médico en caso de quedar embarazadas. Se debe indicar a los pacientes que reciben tratamiento con Micofenolato de Mofetilo que comuniquen inmediatamente cualquier evidencia de infección, contusiones no esperadas, hemorragia, moretones o cualquier otra manifestación de depresión de la medula ósea. Los pacientes tratados con inmunosupresores, incluyendo Micofenolato de Mofetilo, tienen un mayor riesgo para las infecciones oportunistas (bacterianas, micóticas, virales y protozoarias), infecciones mortales y sepsis. Entre las infecciones oportunistas asociadas al virus BK como la nefropatía y al virus JC como Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva (LPM). Estas infecciones suelen estar relacionadas con una elevada carga inmunosupresora total que pueden dar lugar a trastornos graves e incluso mortales para el paciente; los médicos deberán tener esto en cuenta, a la hora de hacer el diagnostico diferencial en los pacientes inmunodeprimidos, que presentan deterioro en la función renal o síntomas neurológicos. Se debe monitorizar a los pacientes que reciben Micofenolato de Mofetilo debido a la neutropenia, la cual puede estar relacionada con el propio Micofenolato de Mofetilo, con medicamentos concomitantes, con infecciones virales, o alguna combinación de estas causas. En los pacientes que toman Micofenolato de Mofetilo deben realizar hemogramas completos una vez por semana durante el primer mes, dos veces al mes para el segundo y tercer mes de tratamiento y a continuación una vez al mes en el primer año. Se debe interrumpir o finalizar el tratamiento

con Micofenolato de Mofetilo, si se desarrollase la neutropenia (recuento absoluto de neutrófilos <1,3 x 10 ul). En pacientes tratados con Micofenolato de Mofetilo en combinación con otros agentes inmunosupresores, se han notificado casos de Aplasia Eritrocitaria Pura (AEP). Se desconoce el mecanismo por el cual el Micofenolato de Mofetilo induce a AEP. La AEP se puede resolver mediante reducción de la dosis o interrumpiendo el tratamiento con Micofenolato de Mofetilo. Cualquier cambio en el tratamiento con Micofenolato de Mofetilo debe llevarse a cabo bajo una supervisión adecuada del paciente que recibe el transplante para minimizar el riesgo de rechazo al injerto. Se debe informar a los pacientes que durante el tratamiento con Micofenolato de Mofetilo las vacunas pueden ser menos eficaces y que debe evitar el empleo de vacunas atenuadas de organismos vivos. Se debe considerar la vacunación contra la gripe, el medico deberá observar las directrices nacionales para la vacunación contra la gripe. Se ha relacionado Micofenolato de Mofetilo con un aumento de la incidencia de efectos adversos en el sistema digestivo, entre los que incluyen casos pocos frecuentes de ulceraciones en el tracto gastrointestinal, hemorragia y perforación, por este motivo Micofenolato de Mofetilo debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedad activa grave del sistema digestivo. El Micofenolato de Mofetilo es un IMPDH (Inosine Monophosphate Dehydrogenase) inhibidor. Por lo que, en teoría, debe evitarse en pacientes con deficiencia hereditaria rara de la Hipoxantina-Guanina Fosforribosil Tranferase (HPGRT) como es el caso del Síndrome Lesch-Nyhan y Kelley-Seegmiller. No se recomienda administrar Micofenolato de Mofetilo al mismo tiempo con Azatioprina, ya que la administración concomitante no se ha estudiado. Teniendo en cuenta la reducción significativa del AUC del MPA que produce la colestiramina, la administración concomitante de Micofenolato de Mofetilo y medicamentos que interfieran en la recirculación enterohepática, debe llevarse a cabo con precaución dada la posibilidad de reducir la eficacia del Micofenolato de Mofetilo. No se ha establecido el balance beneficioriesgo de Micofenolato de Mofetilo en combinación con Tacrolimus o Sirolimus. Se han reportado caos de Hipogammaglobulinemia asociada con infecciones recurrentes en pacientes que reciben Micofenolato (Mofetilo o Sódico) en combinación con otros inmunosupresores. En algunos de los casos notificados, la sustitución del Micofenolato (Mofetilo o Sódico) por otro inmunosupresor, dio lugar a la normalización de los niveles de IGG en suero. En caso de Hipogammaglobulinemia sostenida clínicamente relevante, se deberá considerar la acción clínica más apropiada. Se ha reportado casos de bronquiectasias en adultos y niños que recibieron Micofenolato (Mofetilo o Sódico) en combinación con otros inmunosupresores. En alguno de estos casos la sustitución del Micofenolato (Mofetilo o Sódico) por otro inmunosupresor dio como resultado una mejora en los síntomas respiratorios. El riesgo de las bronquiectasias puede estar vinculado Hipogammaglobulinemia o a un efecto directo sobre el pulmón. También se han aislado informes de Enfermedad Pulmonar Intersticial y Fibrosis Pulmonar, algunos de los casos fueron mortales. Precauciones: - Se recomienda realizar la determinación de inmunoglobulinas séricas a aquellos pacientes en tratamiento con Micofenolato (Mofetilo y Sodio) que desarrollen infecciones recurrentes. - Se recomienda realizar controles periódicos en pacientes que presenten síntomas respiratorios persistentes como tos y disnea.

Registro Sanitario INVIMA 2016M-0017461

Rasandar®
Rasagilina

Rasandar® Tabletas 1mg

FORMA FARMACÉUTICA: Tableta. VÍA ADMINISTRACIÓN: Oral. INDICACIONES: Tratamiento de la enfermedad idiopática de parkinson (pd) en monoterapia (sin levodopa) o en terapia coadyuvante (con levodopa) en pacientes al final de las fluctuaciones de la dosis. CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes. Tratamiento concomitante con otros inhibidores de la monoaminoxidasa (mao) o peptidina. Deben transcurrir al menos 14 días entre la interrupción de la administración de la rasagilina y el inicio del tratamiento con inhibidores de la mao o peptidina. Pacientes con insuficiencia hepática grave. Advertencias: el empleo concomitante con fluoxetina o fluvoxamina: deben transcurrir al menos 5 semanas entre la interrupción de la administración de la fluoxetina y el inicio del tratamiento con rasagilina. Deben transcurrir al menos 14 días entre la interrupción de la administración de rasagilina y el inicio del tratamiento con fluoxetina o fluvoxamina. No se recomienda el empleo concomitante con dextrometorfano o simpaticomiméticos, como los que se encuentran en los descongestionantes nasales y orales o los medicamentos anticatarrales que contienen efedrina o pseudoefedrina. Debe tenerse especial precaución al iniciar tratamiento con rasagilina en pacientes con insuficiencia hepática leve. Su uso debe evitarse en pacientes con insuficiencia hepática moderada. En los casos de progresión de la insuficiencia hepática de leve a moderada debe interrumpirse el tratamiento. No se recomienda en niños ni adolescentes menores de 18 años puesto que no se ha establecido su seguridad y eficacia en esta población.

Registro Sanitario INVIMA 2016M-0017461

Letrocare®
Letrozol

Letrocare® Tabletas recubiertas 2.5 mg

FORMA FARMACÉUTICA: Tableta. VÍA ADMINISTRACIÓN: Oral INDICACIONES: Tratamiento adyuvante en mujeres postmenopáusicas afectas de cáncer de mama incipiente invasivo con receptores hormonales. El tratamiento adyuvante de continuación en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama incipiente invasivo que han recibido previamente tratamiento adyuvante convencional con tamoxifeno durante 5 años. El tratamiento de primera línea en mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama avanzado hormonodependiente. El tratamiento del cáncer de mama avanzado, después de la recidiva o la progresión de la enfermedad, en mujeres en un estado endocrino posmenopáusico natural o inducido artificialmente y que han recibido con anterioridad tratamiento con antiestrógenos.el tratamiento neoadyuvante de mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama her-2 negativo con presencia de receptores hormonales en las que no es adecuada la quimioterapia y no está indicada la intervención quirúrgica inmediata. Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida al principio activo o a cualquiera de los excipientes. Estado endocrino premenopáusico, embarazo, lactancia. Advertencias y precauciones: disfunción renal no se han investigado los efectos de letrozol en pacientes con una depuración de creatinina < 10 ml/min. Antes de administrar letrozol se deben sopesar detenidamente los posibles riesgos y beneficios.

Disfunción hepática en pacientes con disfunción hepática grave (clase c de la escala de child-pugh), la exposición sistémica y la vida media terminal son aproximadamente dos veces mayores que las observadas en voluntarias sanas. En consecuencia, tales pacientes deben someterse a una supervisión rigurosa efectos óseos se han registrado casos de osteoporosis y fracturas óseas con el uso de letrozol. Por consiguiente, se recomienda vigilar la salud ósea general durante el tratamiento estado menopáusico en pacientes cuyo estado menopáusico no se conoce, se medirán las concentraciones de hormona luteinizante (lutropina [lh]), hormona foliculoestimulante (fsh) o estradiol antes de comenzar el tratamiento con letrozol. Solo deben recibir letrozol las mujeres con un estado endocrino posmenopáusico confirmado. Fecundidad la acción farmacológica del letrozol es la reducción de la producción de estrógenos por inhibición de la aromatasa. En las mujeres premenopáusicas, la inhibición de la síntesis de estrógenos comporta un aumento, por retroalimentación, de las concentraciones de gonadotropinas (lh, fsh). A su vez, las concentraciones elevadas de fsh estimulan el crecimiento folicular y pueden inducir la ovulación. Interacciones se evitará la administración simultánea de letrozol con tamoxifeno u otras terapias que contengan antiestrógenos o estrógenos, dado que estos medicamentos pueden disminuir la actividad farmacológica del letrozol. No se sabe cómo se produce esta interacción manejo y uso de máquinas durante el tratamiento con letrozol, se han registrado casos de fatiga y mareos, y también somnolencia de forma ocasional, por lo que se aconseja tener cautela al conducir o utilizar máquinas.
Registro Sanitario INVIMA 2019M-0018944

Referencias:

1. Spínola Franco, Almeida S, Filipe A, et al. Bioequivalence of two formulations of levetiracetam. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2008;46(11)591-596.

2. Almeida S, Pedroso P, Filipe, et al. Bioequivalence of two formulations of Escitalopram. Arzneimittelforschung. 2012;62:307-312.

3. Almeida Susana, Portolés Antonio, Terleira Ana, et al. Comparative Bioavailability/bioequivalence of Two Different Sertraline Formulations. ArzneimForschDrugRes. 2005;55(4):191-197.

4. Sicard Eri. Single Dose Crossover Comparative Bioavailability Study of Memantine 20 mg Film - Coated Tablets in Healthy Male and Female Volunteers. Algorithme Pharma. 201;2-6.

5. Larouche Richard. Pilot Randomized, 3-Way Crossover, Comparative Bioavailability Study of Mirtazapine 30 mg Tablet, Rexer 30 mg Tablet and Remeron SolTab 30 mg Orally Disintegrating Tablet Administered as 1 x 30 mg Tablet or Orally Disintegrating Tablet in Healthy Subjects under Fasting Conditions.sfbc Anapharm. 2004;1-11.

6. Grupo Tecnimede. Single Dose Crossover Comparative Bioavailability Study of Aripiprazole 10 mg Tablets in Healthy Male and Female Volunteers / Fasting State. 2017;1-2.

7. Kirino E1. European Child and Adolescent Psychiatry 21(7):361-368, Jul 2012. Efficacy and Safety of Aripiprazole in Child and Adolescent Patients.

8. Augusto Filipe, Susana Almeida, Pedroso Pedro, et al. Single-Dose, Randomized, Open-Label, Two-Way, Crossover Bioequivalence Study of Two Formulations of Pregabalin 300 mg Hard Capsules in Healthy Volunteers Under Fasting Conditions. CrossMark. 2015;1-7.

9. Almeida S, Filipe A, Neves R, et al. Mycophenolate mofetil 500-mg tablet under fasting conditions: single-dose, randomized-sequence, open-label, four-way replicate crossover, bioequivalence study in healthy subjects. 2010; 32(3):556-74.

10. Algorithme Pharma. Single Dose Replicate Crossover Comparative Bioavailability Study of Rasagiline 1 mg Tablets in Healthy Male and Female Volunteers/ Fasting State. 2014:5-7.

11. Audet D, et al. Randomised, Open-Label, 2-Way Crossover, Bioequivalence Study of Letrozole 2.5 mg Tablet and Femara (Reference) Following a 2.5 mg Dose in Healthy Subjects Under Fasting Conditions. Anapharm. 2007:244-249.